PROTOCOLLO 76

Correzione posturale al lavoro

Ridurre il carico cervicale e mandibolare nelle attività quotidiane

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Lavoro al computer prolungato
- ✓ Uso intenso dello smartphone
- ✓ Dolore che aumenta nella giornata

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: seduto nella postura di lavoro abituale.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Analisi

Valuta la postazione con foto o descrizione.

2



FASE 2

Schermo

Bordo superiore all'altezza degli occhi.

3



FASE 3

Pause

Pause attive ogni 45 minuti.

4



FASE 4

Smartphone

Portare il telefono all'altezza degli occhi.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pause	ogni 45 minuti
Durata pausa	1 o 2 minuti
Verifica	dopo 2 settimane

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE	DOLORE (NRS)	ADERENZA
____ / 10	____ / 10	____ %
masticare, parlare, sbadigliare	peggiore della settimana	esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Modifiche piccole e sostenibili
- ✓ Personalizza alla postazione reale
- ✓ Collega alle pause gli esercizi

Errori da evitare

- ! Indicazioni generiche
- ! Ignorare l'uso dello smartphone
- ! Postura rigida per ore

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Pausa attiva	Retrazione del mento, rotazioni lente e posizione di riposo mandibolare	ogni 45 minuti

! **Nota clinica.** L'ergonomia riduce i fattori di mantenimento quotidiani del dolore.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.